

Recomendaciones para la preparación y cuidados del paciente

Tratamiento con ClearLift en plataforma Harmony

Indicaciones

Fotorejuvenecimiento.
Fotodaño, componente pigmentario.
Mejoría en la calidad y tensión de la piel.
Lesiones pigmentarias benignas en rostro (incluyendo melasma), escote y dorso de manos.
Remoción de tatuajes monocromáticos y colores cálidos.
Estimulación de estrías rubras y albas.
Atenuación de cicatrices, en particular secuelas atróficas del acné.
Ojeras (etiología pigmentaria).
Onicomycosis.

Materiales e insumos

Tratamientos generales

Lentes ciego pacientes (entregados con el equipo)
Lentes operador adecuados para 1064[nm] y/o 532[nm] (entregados con el equipo)
Vinchas o cofias
Agua micelar o toallas desmaquillantes
Cinta hipoalergénica blanca (enmascaramiento de cejas)
Gasas y/o algodón y/o papel para secar
Guantes descartables
Lápiz delineador blanco (marcación y/o enmascaramiento)

Post-tratamiento general

Crema hidratante y/o humectante
Protector solar FPS 50+
Gel descongestivo (opcional post-tratamiento)

Solo en caso de reacción aguda indicar

Hidrocortisona 1[%] tópico (ej. Microsona)
Antihistamínico (ej. Loratadina)

Remoción de tatuajes

Solución de clorhexidina no jabonosa (ej. Pervinox incoloro).
Anestesia tópica (recomendada, ej. Binaff, Pliaglis o EMLA) o infiltrable local.
Packs fríos o Cryo6 (recomendado)
Crema antibiótica (ej. Fusidín crema).
Crema regeneradora (ej. Aquaphor gel, Bepanthen o Cicaplast) o vaselina.
Papel film y cinta hipoalergénica para oclusión evitando roces.

Kit de cuidado e higiene para el domicilio del paciente en caso de remoción de tatuajes

Solo si fuera necesario y según criterio médico dependiendo de la agresividad del tratamiento
Crema antibiótica o solución de clorhexidina no jabonosa.
Crema regeneradora o vaselina.
Papel film y cinta hipoalergénica para oclusión evitando roces.

Limpieza y desinfección de lentes internas de TIPS (al finalizar cada tratamiento)

Alcohol etílico al 70[%] (desinfección de TIP o espaciador en contacto con piel)
Alcohol etílico al 70[%] e hisopos largos (limpieza de lentes internas de TIPS)

Precauciones

- No realice tratamientos con ClearLift sobre fillers o toxina botulínica durante dos semanas posteriores a su aplicación.
- Evitar aspirina y antiinflamatorios 48 horas antes del tratamiento.
- Nunca trabajar en la cercanía de tatuajes (excepto en caso de remoción de tatuajes). Asegurarse de que el paciente no tenga ojos, cejas o labios delineados de forma permanente.
- El paciente idealmente debe evitar la exposición solar previa y posterior al tratamiento.

Preparación del paciente

- En pieles hiperqueratósicas o engrosadas es recomendable realizar un peeling o exfoliación previo a la sesión con el fin de eliminar el estrato corneo y permitir que la luz penetre correctamente en la piel.
- Puede optarse por un tratamiento local previo a la sesión con ácido glicólico y retinoico en bajo porcentaje por la noche, 15 días antes de la sesión, para preparar la piel.
- Un pre-tratamiento con tópicos despigmentantes (hidroquinona) y/o rutina domiciliaria para pacientes con fototipos de III a IV o pieles con fotodaño severo, puede ser útil para reducir el riesgo potencial de efectos adversos e hiperpigmentación.
- Indicar siempre una hidratación y humectación diaria adecuada de la piel con adecuada fotoprotección.

Tratamiento

- Indicar al paciente que evite maquillaje denso para concurrir al consultorio.
- Limpiar la piel con un producto no alcohólico removiendo maquillaje, lociones y/o cremas en la zona de tratamiento. Retirar todos los accesorios como aros, colgantes, etc.
- Colocar cofia y/o vincha al paciente. Cubrir cejas, nevus y tatuajes según corresponda.
- Únicamente en caso de remoción de tatuaje colocar anestesia tópica dejando actuar dependiendo de la recomendación del fabricante. Remover con solución de clorhexidina.
- Si corresponde, con lápiz delineador blanco delimitar el área o lesiones a tratar.
- Colocar lentes ciegos de protección al paciente. Utilizar lentes operador según corresponda.
- Seleccionar el TIP (haz entero, pixelado, KTP, etc.) y definir los parámetros de tratamiento (energía por pulso y frecuencia) en función de la indicación y características de la piel/lesión en base al protocolo recomendado.
- Realizar el tratamiento siguiendo la técnica sugerida.
- Durante el tratamiento podrá escucharse un sonido fuerte (efecto fotoacústico) cuando se trabaja de forma superficial. El enrojecimiento y leve edema es normal. En cientos casos puede existir Petequias y púrpura. Tratamientos agresivos pueden generar sangrado y costras.
- La lesión pigmentaria y tatuaje puede “blanquearse” instantáneamente. Este efecto se conoce como “frosting” y es el endpoint en el caso de tratamiento de tatuajes. No superponer pulsos sobre el frosting.
- Aplicar gel descongestivo si fuera necesario. Colocar crema hidratante/humectante y protector solar.
- En el caso de tatuajes, enfriar la piel antes, durante y luego del tratamiento (recomendado, ej. Cryo6 o packs fríos). Colocar fina capa de crema antibiótica (si la piel resultara dañada durante el procedimiento) y crema regeneradora o vaselina, luego ocluir con film.
- Indicarle al paciente los cuidados a seguir: La zona tratada no debe estar expuesta a la luz solar ni artificial, debe estar totalmente cubierta y protegida, fotoprotección extrema (FPS 50+). Para evitar la pigmentación post-inflamatoria, renovar la aplicación de protector solar cada dos horas. En caso de tatuajes indicar cuidados pertinentes.

Evolución

La piel puede verse con eritema, leve edema, Petequias y/o purpura luego del tratamiento. Durante este periodo se debe mantener la piel debidamente hidratada/humectada y protegida del sol. El periodo de inactividad post-tratamiento será nulo. Si el tratamiento fuera agresivo podrían formarse costras, puntilladas o continuas, sobre la piel/lesión las cuales caerán luego de una o dos semanas. Mantener la piel debidamente hidratada/humectada y protegida del sol.

En el caso de tatuajes se recomienda aplicar finas capas de crema antibiótica (si la piel resultara dañada durante el procedimiento) y crema regeneradora o vaselina, luego ocluir con film a fin de evitar el rose. El paciente puede reaplicar crema regeneradora o vaselina a demanda para evitar picazón y tirantes de la piel (de un modo similar a la curación que se realiza luego de realizarse el tatuaje). Dependiendo de la agresividad del tratamiento, si existe daño severo de la piel, el paciente deberá realizar curas los días posteriores de forma domiciliaria. Según criterio médico podría ser necesaria crema antibiótica, corticoide tópico y crema reparadora bajo oclusión, hasta que la piel sane.

Cuidados posteriores para el paciente

- La sensación de incomodidad será prácticamente nula (excepto en caso de remoción de tatuajes).
- Dependiendo de los parámetros seleccionados para el tratamiento el paciente podrá sentir una mínima sensación de calor o ardor durante 6 a 24 horas.
- Evitar fuentes de calor intensas (calefacción, agua caliente, ceras depilatorias, ventanas del automóvil, etc.) que pudiera aumentar la temperatura de la piel, ya que se incrementará el enrojecimiento e incomodidad.
- La limpieza suave e hidratación o humectación intensa debe realizarse al menos dos veces al día. El uso de los ácidos tópicos podrá ser suspendido dependiendo de la sensibilización o irritación de la piel luego del tratamiento.
- Las posibles costras oscuras, generalmente con el uso del TIP KTP, que pueden formarse después del tratamiento no deberán ser removidas para evitar generar cicatrices. Caerán naturalmente luego de una o dos semanas posteriores a la sesión.
- La zona tratada debe ser protegida de la luz solar y artificial. Indicar fotoprotección (FPS 50+) para evitar la pigmentación posterior, renovando la aplicación cada dos horas. Se sugiere protector fluido sin color en el caso de que existan costras y protector compacto con color si no las hay o luego de que caigan.
- La siguiente sesión se realizará de acuerdo a la indicación profesional, teniendo como referencia la evolución, respuesta de la piel y parámetros utilizados en la sesión previa.
- El paciente deberá informar al profesional médico responsable del tratamiento si existe dolor, hinchazón excesiva, ampollas o cualquier otra respuesta no prevista.